



TXAGORRITXU OSPITALEA
H. TXAGORRITXU

GUINEA IBAÑEZ DE GARAYO
Deiturak / Apellidos

LUIS MARIA
Izena / Nombre

TOMAS ALFARO, 0013 007 A
1008 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)

Helbidea / Dirección

URGENCIA

URGENCIAS DE MEDICINA

Historia Zk. / Nº Historia **IKK** / CIC **Gizarte Segurantz Zk.** / Nº Seguridad Social **Jaiotze Data** / F. Nacimiento
536665 **1164816** **10015586764** **15/05/1956**

Gertakari Zk. / Nº Episodio **Sarrera Data** / F. Ingreso **Alta Data** / F. Alta **Zerbitzu** / Servicio
2773618 **25/06/2022 18:11** **25/06/2022 20:58** **URGENCIAS GENERALES**

Profesional / Profesional
LEANIZBARRUTIA ALONSO, GARAZI

Varón de 66 años que acude por mareo.

ANTECEDENTES PERSONALES:

- Sin alergia medicamentosas conocidas.
- HTA y dislipemia en tratamiento farmacológico.
- Primer episodio de FA, revertida con Vernakalant en octubre 2019. Posterior control en CCEE de Cardiología; ecocardiograma en nov/2019 con FE conservada, AI dilatada ligera. Dado de alta en abril/2020.
- Segundo episodio de FA 05/2020 Revertida con Vernakalant. Se inicia edoxaban. Última consulta 24/08/2020.
- Accidente de bicicleta en el año 2003: TCE grave con fractura de base craneal y fractura temporal izquierda. Hematoma epidural temporal izquierdo. Hematoma subdural temporo-parietal izquierdo. Hemorragia subaracnoidea traumática. Importante desviación de línea media con borramiento de cisternas basales. Preciso tratamiento de rehabilitación por presentar una afasia mixta de predominio motor. Discreta hemiparesia derecha.
- Epilepsia. Última crisis en 2010, generalizada tónico clónicas.
- Fístula arteriovenosa dural del seno sigmoide derecho tratada endovascularmente 17 de septiembre de 2018. En control por neuroradiología. Ingresó en junio/19 para control angiográfico con resultado de correcta embolización.

- Antecedentes quirúrgicos:

Varices (Dic 2017). Sutura tendón mano 2017 con AG, evacuación de hematoma subdural y epidural y craneotomía descompresiva por TCE grave en 2003. Fractura húmero

- Tratamiento habitual:

- Edoxaban 60 mg 1 comprimido 24 horas
- Apocard 100mg 2 comprimido 24 horas
- Atenolol 100mg 1 comprimido desayuno
- Felodipino 5mg 1 comprimido desayuno
- Simvastatina 20mg 1 comprimido acostarse
- Lamotrigina 100mg 1 comprimido desayuno y cena
- Lorazepam 1mg 1 comprimido acostarse

ENFERMEDAD ACTUAL:

Acude por inicio esta mañana de episodio autolimitado de mareo con giro de objetos, e inestabilidad en la marcha con caída hacia la derecha. Posteriormente ha presentado misma clínica por la tarde tras comer. Niega alteraciones visuales, sensitivas (salvo hipoestesia y reducción de la fuerza en hemicuerpo derecho habitual tras

FIRMADO:

010104459 LEANIZBARRUTIA ALONSO, GARAZI

FECHA INFORME: 25/06/2022

HORA INFORME: 21:07

PÁGINA: 1 / 3



Osakidetza

TXAGORRITXU OSPITALEA
H. TXAGORRITXU

URGENCIA

URGENCIAS DE MEDICINA

GUINEA IBAÑEZ DE GARAYO

Deiturak / Apellidos

LUIS MARIA

Izena / Nombre

TOMAS ALFARO, 0013 007 A

1008 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)

Helbidea / Dirección

TCE), ni otra focalidad neurológica. Niega fiebre, ni otra sintomatología añadida en la anamnesis por aparatos.

EXPLORACIÓN GENERAL:

Bien nutrido e hidratado. Buena coloración de piel y mucosas. Eupneico en reposo.

.- Constantes vitales:

- Temperatura: 36.4 °C.
- Tensión Arterial: 141/79 mmHg
- Pulso: 68 p.p.m.
- Frecuencia respiratoria: 19 r.p.m.
- Pulsioximetría: 96 % (a.a.)

.- Cabeza y cuello: Orofaringe normal. No palpación de adenopatías. No IY.

* Otoscopia IZQDA: normal.

* Otoscopia DCHA: normal.

.- A.C.: Rítmica. No oigo soplos, roces ni extratonos.

.- A.P.: Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.

.- Abdomen: Blando y depresible. No doloroso a la palpación. No defensa ni signos de irritación peritoneal.

.- EE.II.: No edemas. No semiología de TVP. Pulsos pedios presentes y simétricos.

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA:

.- Consciente, orientado temporo-espacialmente y colaborador.

.- Pupilas isocóricas y normorreactivas.

.- Escala de Glasgow: 15/15.

.- No rigidez de nuca.

.- No claudicación de extremidades ni otros déficits motores.

.- Reflejos osteotendinosos conservados.

.- Reflejo cutáneo-plantar en flexión bilateral.

.- No déficits en la sensibilidad superficial (algésica).

.- Pares craneales:

- MOE normales.

- Campimetria por confrontación normal.

- Facial: Normal.

- Resto de pares normal.

- Dix-Hallpike: positiva hacia la derecha con nistagmo horizontal que agota.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

.- Analítica sanguínea:

BIOQUÍMICA SUERO

-Glucosa	106 mg/dL	60 - 110
-Urea	25 mg/dL	10 - 50

FIRMADO:

010104459 LEANIZBARRUTIA ALONSO, GARAZI

FECHA INFORME: 25/06/2022

HORA INFORME: 21:07

PÁGINA: 2 / 3

15



LUIS MARIA
Izena / Nombre

Helbidea / Dirección

URGENCIA

URGENCIAS DE MEDICINA

Suero/plasma hemolizado

-Bilirrubina	0,4 mg/dL	<1,3
-Sodio	143 mEq/L	135 - 146
-Potasio	5,2 mEq/L	3,5 - 5,5
-Cloruro	103 mEq/L	95 - 110
-Proteína C reactiva (PCR)	1,6 mg/L	0,00 - 5,00

HEMATOLOGÍA GENERAL

-Hemograma

-Hemáties	5,11 *10 ⁶ /μL	4,5 - 5,9
-Hemoglobina	15,6 g/dL	13 - 17,7
-Hematocrito	49,1 %	40 - 53
-Volumen corpuscular medio (VCM)	96,2 fL	78 - 101
-Amplitud de distribución eritrocitaria (ADE) * 11,4 %		11,5 - 14,5
-Hemoglobina corpuscular media eritrocitaria (HCM)	30,6 pg	27 - 33
-Concentración de hemoglobina corpuscular media	31,8 g/dL	30,5 - 35,5
-Plaquetas	180 *10 ³ /μL	100 - 450
-Volumen plaquetario medio (VPM)	8,3 fL	7,4 - 11
-Leucocitos	5,32 *10 ³ /μL	4 - 11

-Formula leucocitaria

-Neutrófilos	61,30 %	30 - 70
-Linfocitos	28,20 %	25 - 50
-Monocitos	10,20 %	0 - 20
-Eosinófilos	0,30 %	0 - 5
-Basófilos	0,03 %	0 - 1
-Neutrófilos	3,26 *10 ³ /μL	1,5 - 7,7
-Linfocitos	1,50 *10 ³ /μL	1,1 - 4,5
-Monocitos	0,54 *10 ³ /μL	0,1 - 1,0
-Eosinófilos	0,02 *10 ³ /μL	0 - 0,5
-Basófilos	0,00 *10 ³ /μL	0,0 - 0,2

TRATAMIENTO RECIBIDO EN URGENCIAS:

.- Maniobra de Epley

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:

VÉRTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO BENIGNO

TRATAMIENTO DE ALTA:

- Sulpiride 50mg cada 8 horas mientras persista la clínica vertiginosa (Giro de objetos). STOP en cuanto remita la clínica vertiginosa.
- Ejercicios de Brandt-Daroff (Hojas de información a pacientes)
- Control por su MAP.

FIRMADO:

010104459 LEANIZBARRUTIA ALONSO, GARAZI

FECHA INFORME: 25/06/2022

HORA INFORME: 21:07

PÁGINA: 3 / 3

15